NEURO · NE-03

Traumatisme crânien · rachis cervical

NICE NG232 (2023) · CCR
indications et délais du scanner chez l'adulte et l'enfant

SCANNER CÉRÉBRAL · ADULTE (≥ 16 ANS)

Scanner dans l'heure

- GCS ≤ 12 à l'arrivée aux urgences
- GCS < 15 deux heures après le traumatisme
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base : hémotympan, ecchymose périorbitaire, rhinorrhée ou otorrhée de LCR, signe de Battle
- Crise convulsive post-traumatique
- Déficit neurologique focal
- Plus d'un vomissement

Scanner dans les 8 h

- Traitement **anticoagulant** (hors aspirine seule) : à envisager dans les 8 h, même sans autre facteur de risque
- Perte de connaissance ou amnésie, associée à : âge ≥ 65 ans, trouble de l'hémostase, mécanisme dangereux (piéton, éjection, chute > 1 m ou 5 marches), amnésie rétrograde > 30 min

Enfant (NICE NG232) : scanner dans l'heure si suspicion de maltraitance, convulsion post-traumatique, GCS < 14 (< 15 avant 1 an), GCS < 15 à 2 h, fontanelle tendue, signe de fracture de la base, déficit focal, ecchymose ou plaie > 5 cm avant 1 an ; ou si ≥ 2 critères parmi PC > 5 min, somnolence, ≥ 3 vomissements, mécanisme dangereux, amnésie > 5 min (1 seul : surveillance 4 h).

CANADIAN CT HEAD RULE (ADULTE, GCS 13–15, PERTE DE CONNAISSANCE OU AMNÉSIE)

Haut risque (lésion neurochirurgicale)

- GCS < 15 à 2 h
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base
- ≥ 2 vomissements
- Âge ≥ 65 ans

Risque moyen (lésion au scanner)

- Amnésie rétrograde ≥ 30 min
- Mécanisme dangereux : piéton renversé, éjection d'un véhicule, chute > 1 m ou 5 marches

Règle non applicable : anticoagulés, convulsions, âge < 16 ans, traumatisme pénétrant.

RACHIS CERVICAL · CANADIAN C-SPINE RULE (ADULTE CONSCIENT, GCS 15, STABLE)

1 · Facteur de haut risque ?
Âge ≥ 65 ans, mécanisme dangereux, paresthésies des membres
Oui → imagerie

›

2 · Facteur de bas risque permettant l'examen ?
Choc arrière simple, assis aux urgences, a marché, douleur retardée, pas de douleur médiane
Aucun → imagerie

›

3 · Rotation active 45° droite et gauche ?
Oui → pas d'imagerie
Non → imagerie

Adulte : **scanner** en 1re intention si imagerie indiquée (plutôt que radiographies). IRM si déficit neurologique ou suspicion de lésion ligamentaire. Non applicable : grossesse, paralysie aiguë, rachis pathologique, âge < 16 ans.

LECTURE DU SCANNER · CHECK-LIST

Collections
extradurale (biconvexe), sous-durale (croissant), hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire

Parenchyme
contusions, lésions axonales diffuses (IRM plus sensible), œdème

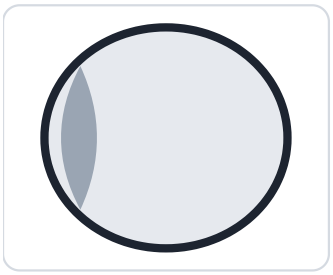
Effet de masse
déviation de la ligne médiane en mm, engagement, citernes

Os
fenêtre osseuse, reconstructions 3D, base du crâne, rochers, face

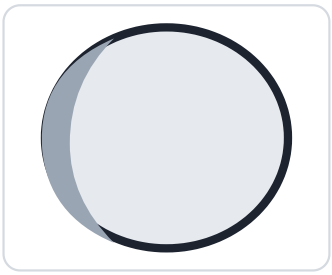
Traumatisme crânien · rachis cervical (suite)

ATLAS VISUEL

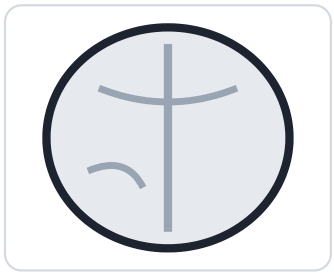
Collections et lésions post-traumatiques



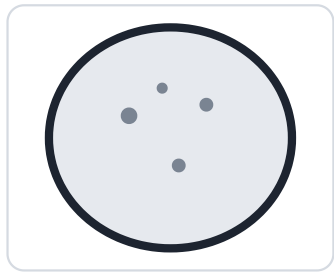
Extradural
biconvexe, ne franchit pas les sutures



Sous-dural
croissant, franchit les sutures



Sous-arachnoïdienne
sillons, citernes, scissures



Lésions axonales diffuses
pétéchies jonctionnelles · IRM (SWI)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hématome extradural
Radiopaedia · aspect, pièges
radiopaedia.org/articles/extradural-haemorrhage

Hématome sous-dural
Radiopaedia · âges de l'hématome
radiopaedia.org/articles/subdural-hemorrhage-2?l

Lésions axonales diffuses
Radiopaedia · grades, IRM
radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury

Canadian CT Head Rule
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/canadian-ct-head-rule?l

Protocole scanner cérébral
Radiopaedia · acquisition et fenêtres
radiopaedia.org/articles/ct-head-protocol?lang=u

NICE NG232 (2023)
Recommandation complète
www.nice.org.uk/guidance/ng232

Sources : NICE NG232 Head injury (2023) – www.nice.org.uk/guidance/ng232/resources/head-injury-assessm... · Canadian C-Spine Rule – www.neuropt.org/docs/default-source/cpgs/concussion/concussi... · Cochrane – CCR et NEXUS – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6494628/